

**VIA**

Vida Integrada e Autônoma

[← Voltar ao hub](#)

REVISTA ELETRÔNICA · CURADORIA MÉDICO-CIENTÍFICA

# Saúde na Última Semana

Revista Eletrônica VIA sobre os fatos que alteraram o cuidado, a saúde pública e a ciência nesta semana — hierarquizados por relevância, traduzidos em linguagem clara e vinculados às fontes primárias.

• EDIÇÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2026

• SEMANA DE 23–29 DE AGOSTO

• BRASIL

## O QUE ESTE BOLETIM É — E O QUE NÃO É

É curadoria editorial para compreender fatos e orientar decisões informadas.

### NÃO É

triagem, diagnóstico nem fonte de dados epidemiológicos em tempo real. Cada alegação factual relevante aponta para sua fonte primária.

## NESTA EDIÇÃO

# O que mudou na saúde nesta semana

● ATUALIZADO EM 29 DE AGOSTO DE 2026

[Ir para o conteúdo](#)

NO I

[Saúde digital](#) · [Clima](#) · [Saúde mental](#) · [Equidade](#) · [Vigilância](#)

#### 01 · EM FOCO

**O SUS pactua uma política nacional de saúde digital**

#### 02 · PREPARAÇÃO

**El Niño 2026–2027 entra no planejamento sanitário**

#### 03 · ACESSO

**Saúde mental chega ao Meu SUS Digital**

#### 04 · VIGILÂNCIA

**Sarampo permanece em risco muito alto nas Américas**

#### 05 · PRÁTICA

**O que muda para pessoas e serviços**

Revista editorial de utilidade pública, compilada de fontes oficiais e da literatura científica na data acima. Números mudam a cada semana — confira sempre a fonte antes de agir ou compartilhar.

## 01 · EM FOCO

# O SUS pactua uma política nacional para informação e saúde digital

Em **27 de agosto**, a Comissão Intergestores Tripartite pactuou a Política Nacional de Informação e Saúde Digital. A decisão é estrutural: União, estados e municípios passam a compartilhar uma direção comum para integrar dados, ampliar telessaúde e tornar a informação utilizável no cuidado — não apenas acumulada em sistemas que não conversam.

#### DECISÃO

### Pactuação tripartite

A política foi acordada na instância que reúne os três níveis de gestão do SUS. Isso lhe dá alcance federativo; não a

**Ir para o conteúdo** [», em](#)  
[ronta.](#)

#### PROMESSA CONCRETA

### Dados úteis no ponto de cuidado

O ganho real não é “digitalizar” mais formulários. É reduzir repetição, perda de informação e decisões tomadas com prontuários incompletos.

- Direção comum para informação e saúde digital.
- Integração entre gestão, vigilância e assistência.
- Governança compartilhada entre entes do SUS.

- Continuidade entre níveis de atenção.
- Menos exames e cadastros repetidos.
- Informação longitudinal acessível com finalidade clínica.

#### CONDIÇÃO

### Interoperabilidade não nasce de decreto

A política só produzirá cuidado melhor se vier acompanhada de padrões técnicos, identificação segura, qualidade de dados e responsabilidades verificáveis.

- Semântica comum entre sistemas.
- Privacidade e controle de acesso proporcionais ao risco.
- Auditoria de uso e correção de registros.

#### LIMITE

### Aplicativo não substitui rede assistencial

Telessaúde e acesso digital podem ampliar alcance, mas excluem quando se tornam a única porta de entrada ou ignoram conectividade, letramento e deficiência.

- Preservar alternativas presenciais.
- Projetar para acessibilidade e baixo consumo de dados.
- Medir desfechos, não apenas acessos à plataforma.

#### LEITURA VIA

## Infraestrutura só vale se reduzir a distância entre informação e decisão

A política cria uma condição institucional favorável. O teste real será observar se a informação chega íntegra, compreensível e a tempo de alterar o cuidado.

- Qual dado precisa existir para esta decisão?
- Quem responde por sua qualidade e atualização?

... e, para isso, por qual finalidade e com qual registro?

[Ir para o conteúdo](#)



## O que aconteceu — sem inflar a notícia

Foi pactuada a política nacional. Implementação, padrões, cronograma e efeitos sobre o atendimento ainda precisam ser acompanhados. Confundir decisão normativa com sistema entregue seria vender a maquete como edifício. Na mesma reunião foram pactuados nove medicamentos, o programa de eliminação da tuberculose e a política de saúde da população quilombola.

Anúncio oficial · Ministério da Saúde ↗

## 02 · CLIMA E PREPARAÇÃO

# El Niño 2026–2027 entra no planejamento sanitário

O Ministério da Saúde apresentou aos secretários estaduais um plano de preparação e resposta para emergências associadas ao próximo ciclo do El Niño. A notícia relevante não é o nome do fenômeno: é a tentativa de antecipar efeitos previsíveis sobre território, doenças e capacidade assistencial.

JANELA CRÍTICA · OUT. 2026 – MAR. 2027

### Preparar antes do evento

O plano organiza a resposta do SUS a impactos climáticos previstos para a janela de outubro a março. O valor está em

**Ir para o conteúdo** n estoque, vigilância,

RISCOS COMBINADOS

### Calor, chuva e deslocamento

Eventos extremos alteram água, vetores, alimentos, abrigo e acesso aos serviços. O efeito sanitário não é uma doença isolada,

comunicação e capacidade local antes da ruptura.

mas uma cascata de exposições e interrupções.

#### ESCALA LOCAL

### O município é onde o plano encontra o corpo

Alertas só ganham utilidade quando chegam a territórios vulneráveis com protocolos simples: quem monitora, qual limiar dispara ação e para onde pessoas e equipes se deslocam.

### Repercussão prática

Famílias e serviços podem revisar antecipadamente medicamentos contínuos, água segura, contatos de emergência, rotas de acesso e proteção de pessoas dependentes de eletricidade ou refrigeração.

[Plano apresentado ao Conass ↗](#)

## 03 · ACESSO AO CUIDADO

# Saúde mental entra no Meu SUS Digital — com escala e limites

Desde 24 de agosto, o SUS oferece até **100 mil teleatendimentos mensais** em saúde mental para mulheres em situação de violência, mães atípicas e outras mulheres da família — tias, avós, irmãs — que cuidam de pessoas com deficiência, desenvolvimento ou doenças raras. O serviço amplia acesso; não le de rede territorial e resposta presencial.

[Ir para o conteúdo](#)

ACESSO · BRASIL

## Uma nova porta de entrada

O atendimento remoto pode reduzir barreiras geográficas, de tempo e de exposição para quem vive sob violência ou acumula cuidado intensivo de familiares.

CANAL · MEU SUS DIGITAL

## Escala nacional pelo aplicativo

O acesso é pelo miniapp *Acolhe Mais +*, com até 10 sessões por usuário. A experiência precisa ser acompanhada por tempo de espera, continuidade, encaminhamento e capacidade de absorção pela RAPS.

SEGURANÇA · VIOLÊNCIA

## Privacidade não é detalhe de interface

Em situações de violência, notificações, histórico visível e dispositivos compartilhados podem produzir risco. Desenho seguro exige discrição, consentimento e alternativas de acesso.

TAMBÉM NESTA SEMANA · EQUIDADE, REGULAÇÃO E ELIMINAÇÃO

EQUIDADE · SAÚDE QUILOMBOLA

## Política nacional é pactuada no SUS

Em 27 de agosto, gestores federais, estaduais e municipais pactuaram na CIT a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola. A normativa busca enfrentar barreiras de acesso, racismo e desigualdades que atingem mais de **1,3 milhão de pessoas**; pactuação não equivale, por si só, a implementação efetiva nos territórios.

ELIMINAÇÃO · SAÚDE INDÍGENA

## Oncocercose atinge a meta de cobertura

No primeiro semestre, o Brasil alcançou **85,4% de tratamento coletivo** nas comunidades endêmicas da Terra Indígena Yanomami, último foco ativo da doença nas Américas. A meta operacional é de 85%.

ANVISA · DOENÇA RARA

**Primeira indicação específica para  
Ir para o conteúdo**

A Anvisa aprovou o nipocalimabe para adultos e adolescentes a partir de 12 anos com anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes — o Brasil é o primeiro país do mundo a aprovar essa indicação. Registro não equivale a incorporação ao SUS.

### Fonte e escopo

O Ministério da Saúde anunciou a disponibilidade e o público contemplado. Detalhes operacionais devem ser conferidos no Meu SUS Digital e nos canais oficiais antes de orientar uma pessoa específica.

[Anúncio oficial do serviço ↗](#)

## 04 · VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

# Sarampo permanece em risco muito alto nas Américas

O alerta epidemiológico da OPAS, publicado em 7 de agosto e ainda o documento regional mais recente no fechamento desta edição, classifica o risco regional como muito alto. Até a semana epidemiológica 28, encerrada em 18 de julho, haviam sido confirmados **47.459 casos** em 16 países e um território, com **44 mortes**. O foco editorial aqui não é manter sarampo por tradição: é não descartar um risco relevante enquanto ele continua ativo.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICO · OPAS/OMS · 7 DE AGOSTO DE 2026

A região registrou o maior número de casos confirmados em **22 anos**. A OPAS relaciona o

[Ir para o conteúdo](#) os, lacunas de imunização e alta mobilidade, e recomenda vacinação,

vigilância sensível, busca ativa e resposta rápida a casos suspeitos.

Números absolutos envelhecem rapidamente. Por isso, esta edição registra a semana epidemiológica de referência e vincula diretamente o alerta; não transforma dado de julho em contador “ao vivo”.

Organização Pan-Americana da Saúde. *Alerta Epidemiológico: Sarampo na Região das Américas*. 7 ago. 2026. **Documento oficial** ↗

#### BRASIL • SITUAÇÃO NACIONAL DECLARADA

Em 13 de agosto, o Ministério da Saúde registrava **24 casos de sarampo no Brasil em 2026**, todos relacionados à importação do vírus: três encerrados sem risco de disseminação e 21 em acompanhamento em São Paulo — 18 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. O país mantém a recertificação de eliminação da circulação endêmica, recebida da OPAS em novembro de 2024.

É esse o dado que sustenta a distinção operativa desta edição: risco regional elevado com casos importados sob rastreamento não é o mesmo que circulação endêmica restabelecida. A afirmação vale na data da fonte e deve ser reconferida antes de ser repetida.

Ministério da Saúde. *Alerta sobre sarampo nas Américas reforça importância de intensificar vacinação no Brasil*. 13 ago. 2026. **Fonte oficial** ↗

#### BRASIL • CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO

A mobilização para crianças e adolescentes menores de 15 anos segue até **1º de setembro**. Em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista, o Ministério da Saúde mantém vacinação indiscriminada contra sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos: entre 3 e 14 de agosto foram aplicadas mais de **529,8 mil doses** de tríplice viral nessas cidades.

O Dia D já passou; o prazo da campanha ainda não. A ação útil nesta semana é conferir a caderneta na unidade de saúde, sem reiniciar esquemas já começados e sem presumir indicação individual apenas pela idade.

Ministério da Saúde. *Dia D de vacinação contra mais de 20 doenças acontece neste sábado (22) em todo o país*. Atualizado em 21 ago. 2026. **Fonte oficial** ↗

#### SUSPEITA CLÍNICA

### Febre, exantema e contexto importam

**Ir para o conteúdo**



Febre com manchas, tosse, coriza ou conjuntivite, sobretudo após viagem ou contato, exige avaliação e comunicação prévia à unidade para reduzir exposição de terceiros.

#### PREVENÇÃO

### Verifique a caderneta

A indicação depende de idade, histórico vacinal e situações especiais. A unidade de saúde é o lugar adequado para conferir doses e atualizar o que estiver atrasado.

#### COMUNICAÇÃO DE RISCO

### Alerta não é pânico

Risco regional elevado pede vacinação e vigilância proporcionais. Não autoriza afirmar circulação sustentada em qualquer município sem dado local correspondente.

## 05 · AÇÃO PRÁTICA

# O que muda para pessoas e serviços

Cinco ações proporcionais aos fatos desta edição — sem transformar notícia institucional em obrigação individual imaginária.



### Atualize a caderneta até 1º de setembro

A Campanha Nacional de Multivacinação continua aberta para pessoas com 15 anos. Leve a



### Em suspeita de sarampo, avise antes de chegar

Febre com manchas após viagem ou contato merece avaliação. Telefonar para a unidade permite

[Ir para o conteúdo](#)

**VIA**

Vida Integrada e Autônoma

caderneta; a equipe confere o que realmente está indicado.

organizar fluxo e reduzir exposição de outras pessoas

[← Voltar ao hub](#)

### Revise o plano doméstico para eventos climáticos

Cheque água segura, medicamentos contínuos, contatos, rotas e necessidades de pessoas dependentes de energia, refrigeração ou cuidadores.



### Conheça a nova porta de saúde mental

Se pertencer ao público anunciado, abra o Meu SUS Digital em *Miniapps* e procure *Acolhe Mais +*. Em urgência, risco de violência ou crise grave, procure a rede presencial e os canais de emergência.



### Se trabalha no SUS, acompanhe a implementação

A nova política de saúde digital será julgada por padrões, integração, segurança e efeito no cuidado. Conte sistema lançado; não conte slide apresentado.

## TRANSPARÊNCIA

### MÉTODO EDITORIAL

#### A fonte não é a ferramenta.

Cada edição parte dos fatos publicados na semana e os hierarquiza por relevância clínica, sanitária ou institucional. A revista organiza e interpreta; não gera dados. Alegações epidemiológicas, regulatórias e quantitativas apontam para fonte oficial específica, com data e existe documento técnico, para ele. Uma notícia só permanece em edições

[Ir para o conteúdo](#)

posteriores quando continua materialmente ativa, com dado datado que o demonstre — tema recorrente não se torna foco automático.

[Voltar ao hub](#)

## Ministério da Saúde · 27 ago. 2026

Pactuação da Política Nacional de Informação e Saúde Digital



## Ministério da Saúde · 27 ago. 2026

Plano de preparação do SUS para o El Niño 2026–2027



## Ministério da Saúde · 24 ago. 2026

Teleatendimentos de saúde mental pelo Meu SUS Digital



## Ministério da Saúde · 29 ago. 2026

Pactuação da Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola



## OPAS/OMS · 7 ago. 2026

Alerta epidemiológico de sarampo nas Américas



## Ministério da Saúde · 13 ago. 2026

Situação do sarampo no Brasil: 24 casos importados e recertificação de eliminação



## Ministério da Saúde · atualizado em 21 ago. 2026

Campanha Nacional de Multivacinação até 1º de setembro



## Ministério da Saúde · 27 ago. 2026

Marco de pré-eliminação da oncocercose na Terra Indígena Yanomami



## Anvisa · 25 ago. 2026

Primeira indicação específica no Brasil para anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes



**Ir para o conteúdo**

**VIA**

Vida Integrada e Autônoma

**VIA**

Vida Integrada e Autônoma

[← Voltar ao hub](#)**DIREÇÃO CLÍNICA****Dr Lucas HR**

Médico Generalista (FMRP-USP)

CRM-SP: 226836 | CRM-MG: 109752

**WhatsApp Business: +55 16 99618-0196****Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.****Conheça a Iniciativa VIA →****ESTE BOLETIM**

Utilidade pública e educação em saúde.

**Código e versões ↗**

Conteúdo educativo, sem finalidade diagnóstica ou terapêutica. Não substitui a consulta com profissional de saúde nem os canais oficiais de vigilância. Diante de sinais de alerta, procure uma unidade de saúde ou o serviço de emergência.

© 2026 INICIATIVA VIA

PUBLICADO VIA GITHUB PAGES

[Substack ↗](#)[YouTube ↗](#)[Instagram ↗](#)[Medium ↗](#)[GitHub ↗](#)[Doctoralia ↗](#)[WhatsApp ↗](#)**Dr Lucas HR Almeida** — Médico Generalista (FMRP-USP) · CRM-SP 226836 | CRM-MG 109752

Iniciativa VIA — Vida Integrada e Autônoma · Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.

[Iniciativa VIA](#) · [Sobre o fundador](#)